

УДК: 618.11-002-07

А.К.Адилшин, Ш.К.Адилшина

Северо-Казахстанский облонкодиспансер

Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д. Асфендиярова

Синдром Мейгса. Ошибки диагностики

Аннотация. В статье приводится картина синдрома Мейгса, а также обсуждаются причины ошибок диагностики данного состояния. Демонстрируется случай из клинической практики.

Ключевые слова: Синдром Мейгса, диагностика, ошибки.

Синдром Мейгса – Meigs, синдром Meigs-Cass, синдром Demons- Meigs – описан американским хирургом Meigs Joe Vincent (1892-1963) и Мейгсом и Касса в 1935 году, как сочетание доброкачественной опухоли яичника, асцита и гидроторакса (1,4). Полная триада наблюдается не всегда.

Чаше встречается при фибромах яичника.

Соответственно гистологической классификации опухолей яичников (ВОЗ, Женева, 1977), данная опухоль – «аденофиброма и цистаденофиброма», описывается как «эпителиальные опухоли» в группе как доброкачественных, так и пограничных опухолей (3).

Фибромы составляют около 4% всех опухолей яичников, не обладают выраженной гормональной активностью, поражают чаще лиц пожилого возраста, сопровождаясь полисерозитом – гидроторакс, асцит, крайне редко и гидроперикард – синдром Мейгса (1).

Субъективная картина заболевания скудная. Жалобы на односторонние боли в нижней части живота неинтенсивного характера, зачастую описываемые как «дискомфорт в животе», сменяются жалобами на распирание брюшной стенки, нарастающую одышку, сердцебиение.

Объективное обследование выявляет клиническую картину, иногда приводящую к ошибочному диагнозу. Так, при аускультации легких выявляется картина «плеврита», чаще правостороннего. При исследовании органов брюшной полости-асцит. При гинекологическом обследовании – опухоль яичника.

Фиброма яичника – достаточно редкое заболевание, всего 4% среди всех опухолей этого органа. Мы не нашли сведений о частоте синдрома Мейгса,

С синдромом Мейгса более знакомы онкогинекологи, менее – гинекологи общей лечебной сети и совсем редко-терапевты, участковые и семейные врачи.

Все вышеуказанное является поводом для демонстрации нашего случая из практики.

Б-ая У.Б., 51г. поступила в Северо –Казахстанский онкодиспансер с жалобами на дискомфорт в животе, увеличение живота в объеме. Из анамнеза : считает себя больной с марта 2012 г, при обращении к гинекологу был поставлен диагноз «миома матки», диагноз подтвержден при УЗИ-исследовании. В апреле 2012 г. по поводу увеличения живота обратилась к терапевту, проводилась симптоматическая терапия.

В связи с отсутствием лечебного эффекта самостоятельно прошла УЗИ-исследование, был поставлен диагноз – гепатоз, гепатомегалия, асцит. Терапевтом

направлена к гастроэнтерологу , проведен курс терапии по поводу данного состояния, однако улучшения не было, асцит не поддавался терапии. При динамическом УЗИ - исследовании органов брюшной полости 18.07. 2012г. выставлен диагноз «гепатомегалия, цирроз печени, асцит», лечение продолжено у гастроэнтеролога другой поликлиники. Из- за неэффективности проводимой терапии в сентябре 2012 г. направлена на стационар в гастроэнтерологическое отделение Северо-Казахстанской областной больницы.

УЗИ гениталий от 10.09.2012г- миома матки, асцит, объемное образование , исходящее из малого таза. ФГДС от 10.09.2012 – без патологии. Ирригоскопия от 12.09.2012- спастический колит. МРТ органов брюшной полости 11.09.2012г, заключение - 2-хсторонний гидроторакс, асцит, объемное образование малого таза солидного характера, распространяющееся в брюшную полость. Стацлечение в течение 9 дней. Осмотрена торакальным хирургом, сделаны УЗИ плевральных полостей с торакоцентезом, ПЗС с взятием жидкости на онкоцитологию. Цитологически - без атипии,

Первичный осмотр онкогинекологом 13.09.2012 г. Рекомендовано перевести в облонкодиспансер.

Стацлечение в облонкодиспансере с 14.09.12г., госпитализирована на диагностическую лапаротомию. Проведен курс дезинтоксикационной терапии, витаминно - общестимулирующая терапия. 14.09.2012г. сделан лапароскопический, проведены УЗИ плевральных полостей, рентгенография легких, консультации торакального хирурга и терапевта. Заключение терапевта - АГ II ст, хронический бронхит, киста левой почки ХПН 0, полиартроз , варикозная болезнь. Спирометрия 18.09.2012 – нарушение функции внешнего дыхания I-II ст. Осмотр ангиохирурга от 14.09.2012- варикозная болезнь, ХВН 1 кл.

Маммография по скринингу от VII -2010г. – без патологии. Р –графия легких от 04.09.2012- плеврит справа.

Данные лабораторного обследования – Общий анализ крови 26.09.2012-Гемоглобин-110 г/л, эрит-4,2*10¹²/л. Цв .пок-0,82. Лейк- 8,6*10⁹/л. Пал-5, сегм-74,мон-5,лимф-16. СОЭ-23 мм/час. Общий анализ мочи-24/09/2012- кол-100мл цвет-желтый, прозрачность-полная, отр. плотность-1030, реакция-кислая, сахар-отр, белок-отр, микроскопия осадка- эпит.плоск- 0-2-4 в п/зр , лейкоц-14-16 в п/зр, эритро-0, слизь-отр, соли-отр, ураты-отр,бактерии-отр.. Биохимическое исследование крови -03.09.2012- общий белок-77 г/л, мочевины -6,6 ммоль/л, креатинин-0,077 ммоль/л, глюкоза- 5,84 ммоль/л, тимоловая проба-3,7 ед, холестерин- 4,1 ммоль/л, фибриноген-3,1 г/л, протр. индекс-87%, билирубин-8,5 мкмоль/л, АЛТ-0,44 ед, АСТ-0,21 ед. Мазок на онко/цитологию от 13.09.2012- без атипии. HBsAg и HCV от 05.04.12-отр. RW от 28/08/12 г.№106-отр, ВИЧ от 06.09.12 № 3564- отр.

Подготовлена к операции, операция - 20.09.2012 г. Произведена экстирпация матки с придатками, экстирпация большого сальника, дренирование. В послеоперационном

периоде проведен курс дезинтоксикационной, антибактериальной, гемостатической, антикоагулянтной терапий, профилактика осложнений варикозной болезни. Сделано контрольное УЗ- исследование плевральных полостей 26.09.2012г- жидкости нет. В послеоперационном периоде на 6-е сутки—цистит, получила курс противовоспалительной терапии. Заживление – per grima.

Морфологически - данные ИГХ. Картина клеточной фибромы яичника.

Выписана с рекомендацией - наблюдение у гинеколога в ООД. При повторном осмотре с инструментальным обследованием через 1 и 3 месяца после выписки самочувствие хорошее, признаков асцита и гидроторакса не выявлено.

Как нам кажется, стандартное мышление о том, что в пожилом возрасте увеличение живота и не интенсивные боли в животе связаны чаще с миомой матки привели к первичному диагнозу – « миома матки». Однако, уже через месяц появилось более значительное увеличение живота асцит без указаний в анамнезе сердечной патологии и тогда мысль врача склоняется в пользу гепатоза, гепатомегалии, цирроза печени. Хотя следовало бы подумать о том, что правосторонний гидроторакс не свойственен гепатогенному асциту, а при сердечном гидротораксе – если он односторонний, то как правило жидкость определяется в левой плевральной полости.

Все это при недостаточном сборе анамнеза, неполном клиническом обследовании - не достаточно полном гинекологическом обследовании - недооценка состояния придатков матки при влагалищном обследовании, не проведены бимануальное влагалищно-прямокишечное исследование и динамическое влагалищное обследование после парацентеза и освобождения брюшной полости от асцитической жидкости, гипероценке роли лабораторных инструментальных исследований привело к врачебной ошибке – диагнозу « миома матки», « цирроз печени». А морфологическое исследование удаленного яичника, исчезновение гидроторакса и асцита после операции и отсутствие их при ретроспективном наблюдении через 1 и 3 месяца говорят в пользу синдрома Мейгса.

Когда диагноз непонятен, необходимо как можно раньше созывать консилиум с участием врачей различного профиля.

Ошибка в диагнозе могла стоить человеку жизни, так как полисерозит, прогрессируя, мог привести к сердечной недостаточности, а синдром Мейгса к кахексии, даже при всей его доброкачественности.

Список литературы

1. Лазовский И.Р. Справочник клинических симптомов и синдромов.- М.: Медицина, 1981.
2. Махаринская Е.С. Березняков Е.С. Диагностика и лечения асцита и его осложнений //Болезни и антибиотики.- 2011.-№ 2(05).
3. Селезнева Э., Железнов Б. Доброкачественные опухоли яичников.- М., 1982.
4. Словарь - справочник синдромов и симптомов заболеваний /Под ред. проф. М.Фейгина. - Варшава: Варшавское государственное медицинское издательство, 1965.
5. Тополянская А.В., Бородулин В.И. Синдромы и симптомы в клинической практике: эпонимический словарь справочник.- М., 2010.
6. Тейлор Р.Б. Трудный диагноз /Перевод с англ.- М.: Медицина, 1988.-Т1.-С. 168

Тұжырым

А.К.Адилшин, Ш.К. Адилшина

Солтүстік Қазақстан Аудандық онкодиспансер, С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті

Мейгс синдромы. Диагностика қателіктері

Мақалада Мейгс синдромының көрнісі жазылған, сонымен қатар берілген жаздайды анық таудазы қателіктердің себебі талцаланған. Клиникалық тәжірибедегі болған жаздай баяндалған.

Түйінді сөздер: Мейгс синдромы, диагностика. Қателіктер.

Summary

A.K.Adilshin, S.K.Adilshina

North Kazakhstan Regional Oncology Center, Kazakhsky National Medical University S.D. Asfendiyarov

Meigs' syndrome. Error diagnosis

Using personal experience and analysis of literature the authors give an elucidation of the clinical picture and problem of diagnosis Meigs' syndrome and discusses about reason of diagnostic errors. Also authors demonstrates the case from clinical practice.

Keywords: Meigs' syndrome, diagnostics, error.